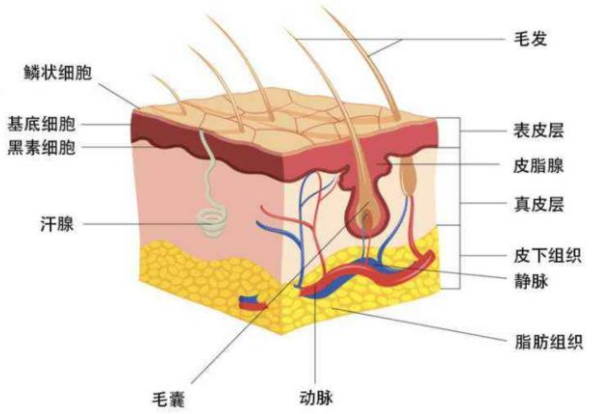
完全修复:肝细胞点状坏死和嗜酸性坏死、急性糜烂性胃炎、I度烧伤(表皮浅层)、浅II度烧伤、骨折、肌腱断裂经功能恢复后

三、烧伤深度（I浅II疱III全层、红红白白）

ttsx	I度	浅II度	深II度	III度
损伤	表皮浅层 无血管	部分表皮生发层或真皮乳头层 （发如雪）	部分真皮网状层	皮肤全层甚至皮下 脂肪、肌肉、骨骼、内脏
创面	红斑状 干燥、无水疱	湿润、红润血管扩张充血 大小不一的水疱 浆液性炎	湿润、红白相间 可有小水疱部分血管被烧烂	蜡白焦黄、炭化、树枝状栓塞血管 干燥、无水疱 全部烧烂
感觉	烧灼感 拔毛剧痛	疼痛显著、感觉过敏 拔毛痛真皮具有大量神经	温度↓、痛觉迟钝 拔毛微痛神经也被烧烂了	发凉、痛觉消失 拔毛不痛（易拔除）
愈合	＜1 周	10 天-2 周（同根除 Hp 疗程）	3-4 周，瘢痕增生	需植皮，瘢痕增生

生发层有丰富干细胞,只要没有被完全损毁,干细胞是健在的就可以不留疤



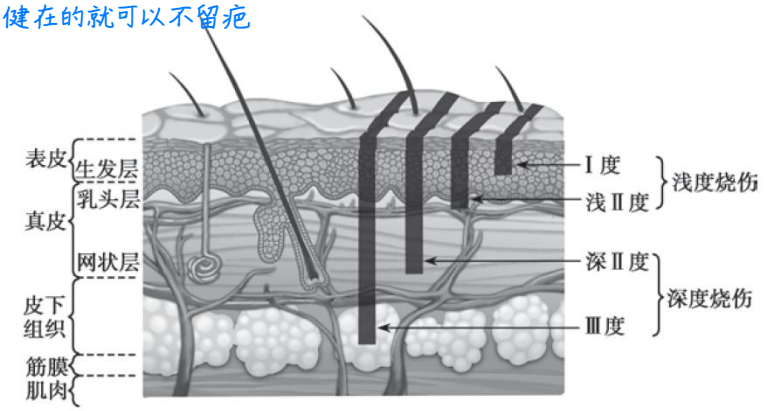


图 10-4　烧伤创面深度的三度四分法

四、烧伤严重程度

13 12 5 医生要爱我	轻	中	重	特重
II度烧伤面积	＜10% 医	11-30% 生		
III度烧伤面积		＜10% 要	11-20% 爱	＞20%
烧伤总面积（I+II+III度）			31-50% 我	＞50%
休克、吸入性损伤、复合伤	没有	没有	可有	可有

至少重度

五、分期

1.体液渗出与回吸收期

①伤后 2-3h 最为急剧、6-8h 达高峰、一般持续 24-48h→低血容量性休克→补液是烧伤患者首选的主要治疗措施

②**第一个 24h 补液量**：

每 1%的II、III度烧伤面积、每 kg 体重补 1.5ml 晶：胶=2：1（广泛深度烧伤时 1：1） +2000ml 葡萄糖溶液 5%的葡萄糖

只要考补液计算题都按2:1算,广泛烧伤当成理论 ↓

前 8h 输入一半，后 16h 输入另一半

（晶体/电解质如平衡盐、胶体如血浆。先快后慢）

注意：I度烧伤不算到烧伤严重程度、不算到补液公式、创面无需特殊处理

③**第二个 24h 补液量**：上述晶胶液减半+2000ml 葡萄糖溶液

不是整体减半